

Вислуховування серцебиття плода

Сценарій (вислуховування серцебиття плода)

Ви лікар акушер - гінеколог. До вас на прийом звернулася вагітна жінка 23 років. Вагітність перша, 38 тижнів. Скарг немає, ворухіння плода відчуває добре. При виконанні прийому зовнішнього акушерського дослідження – спинка плода ліворуч, голівка плода над входом в малий таз. Подальша Ваша тактика- аускультация плода. Ви приступаєте до вислуховування серцебиття плода.

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Перед входом на станцію повинно бути розташоване клінічне завдання (брифінг).

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря акушера- гінеколога приймального відділення, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Годинник із секундною стрілкою	1 шт.
4	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
5	Манекен-симулятор вагітної	1 шт.
6	Манекен-симулятор плоду з серцебиттям	1шт.
7	Медична кушетка (стіл)	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Акушерський стетоскоп	1 шт.
2	Квадратний лоток	1 шт.
3	Секундомір.	1 шт.
4	Антисептик для обробки рук 5 мл.	1 шт.
5	Контейнер для зборі відходів класу А (класу В)	1 шт.

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Гумові рукавички різних розмірів	2 шт

- симуляційне обладнання

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Манекен-симулятор вагітної жінки	1 шт
2	Манекен-симулятор плоду з серцебиттям	1 шт



11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів
(ситуаційних завдань)

Алгоритм виконання		Форма представлення	
1.Продемонструвати навички комунікації.			
1.1	Коректне розташування пацієнт-лікар навпроти (стоячи пацієнтки),	Сказати Доброго дня. Я лікар акушер-гінеколог.	

	встановлення контакту з пацієнткою (привітатись, представитися, позначити свою роль).	
1.2	Отримати інформаційну згоду на проведення маніпуляції.	<i>Сказати Ви даєте свою згоду на проведення вислуховування серцебиття плода (Будемо вважати що згода отримана)</i>
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	<i>Сказати Будемо вважати, що руки оброблені</i>
2. Виконання навички		
2.1	Акушерський стетоскоп покласти на лоток і поставити його поруч. Окремо підготувати секундомір.	<i>Виконати</i>
2.2	Коректно розташуватися до манекена (праворуч та обличчям до манекена).	<i>Виконати</i>
2.3	Коректне виконання II прийому (перемісти руки з дна матки на бічні поверхні живота, пропальпувати та назвати, де розташована спинка плода)	<i>Виконати Сказати «спинка плоду – ліворуч до переду, дрібні частини плоду праворуч, перша позиція передній вид»</i>
2.4	Коректне виконання III прийому, однією рукою охопити передлежачу частину плода. Визначити та назвати частину плоду що передлежить.	<i>Виконати – Сказати «Передлежить щільна балотуюча частина - голівка плода»</i>
2.5	У праву руку візьміть стетоскоп, у ліву руку секундомір. Поставити стетоскоп кінцем з більш широким отвором перпендикулярно до передньої черевної стінки у місце ймовірного вислуховування серцебиття плода. До іншого кінця щільно притисніть вушну раковину та пересуваючи стетоскоп по животу,	<i>Виконати – Сказати «Серцебиття плоду – ліворуч, нижче пупка»</i>

	знайдіть місце найбільш чіткого вислуховування серцебиття плода. В момент вислуховування стетоскоп рукою не тримати (серцебиття – вище, нижче, на рівні пупка, ліворуч, праворуч).	
2.6	Визначте ясність, ритмічність серцевих тонів плода та підрахуйте частоту серцевих скорочень протягом 1 хвилини, використовуючи секундомір.	<i>Виконати</i>
2.7	Порівняйте отримані дані з нормою. (фізіологічний норматив - 110-170 уд./хв., тахікардія: частота серцебиття плода вище 170 ударів за хвилину, брадикардія: частота серцебиття плода нижче 110 ударів за хвилину.)	<i>Виконати – Сказати «серцебиття плода – 145 уд./хв, звучні, ритмічні»</i>
2.8	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	<i>Сказати « Як Ви себе відчуваєте?» (Будемо вважати – добре)</i>
3. Діагностика (встановити попередній діагноз).		
Вагітність 38 тижнів, Перша позиція, передній вид, головне передлежання.	<i>Сказати</i>	
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Динамічний нагляд за вагітною	<i>Сказати</i>
4.2	Визначити метод родорозв'язання (природні пологи/кесарів розтин).	<i>Сказати</i>
4.3	Консультування з питань грудного вигодовування та післяпологового відновлення.	<i>Сказати</i>